BRIGADE DE SAPEURS POMPIERS DE PARIS

eFibi : amélioration des pratiques

FMA des chefs d'agrès
2025 - 2026



Constat

- La majorité des eFiBi en présence d'une équipe médicale sont mal remplies.
- Souvent on ne sait pas quel est le diagnostic supposé du médecin, et si c'est une UMH on ne connait pas le devenir de la victime.
- Il faut demander la permission au médecin de l'UMH de prendre en photo l'observation médicale si elle est déjà rédigée, et sinon lui demander ce qu'il évoque et le noter dans eFiBi.
- Il faut marquer la destination de la victime transportée par l'UMH et la catégorisation.
- C'est connu, puisque c'est noté a posteriori dans la MCO…
- C'est important, car certaines victimes sont prises en charge souvent et on peut ainsi les retrouver dans l'historique sur eFiBi lors d'une prochaine intervention.

Constat

- Sur la journée du 11 novembre 2025 :
  - 44 interventions avec prise en charge par une UMH
  - Seules 5 interventions ont en pièce jointe la photo de l’ observation de l’UMH.
  - Seules 3 interventions mentionnent la destination et aucune ne contient l hypothèse diagnostic de l’UMH.
- C’est pourtant demandé sur la note eFiBi disponible sur le CORPUS.
- De plus en plus de victimes demandent leur eFiBi et il faut donc qu’elles soient bien remplies (assurances, pour le médecin traitant, en cas de décès) : c’est médico-légal.

Bonnes pratiques

- Il faut initier la prise en charge de la victime dès l'arrivée à l'adresse de l'intervention. Ainsi, en cas d'appel urgent, on peut écrire dans eFiBi. Cela trace la décision et facilite l'envoi de l'équipe médicale.
- Il faut coupler la tablette au DGT7 pour que les constantes s'incrémentent automatiquement.
- Il n'y a pas besoin de remplir complètement eFiBi pour demander une équipe médicale au bilan primaire. Il faut quand même savoir justifier sa demande.





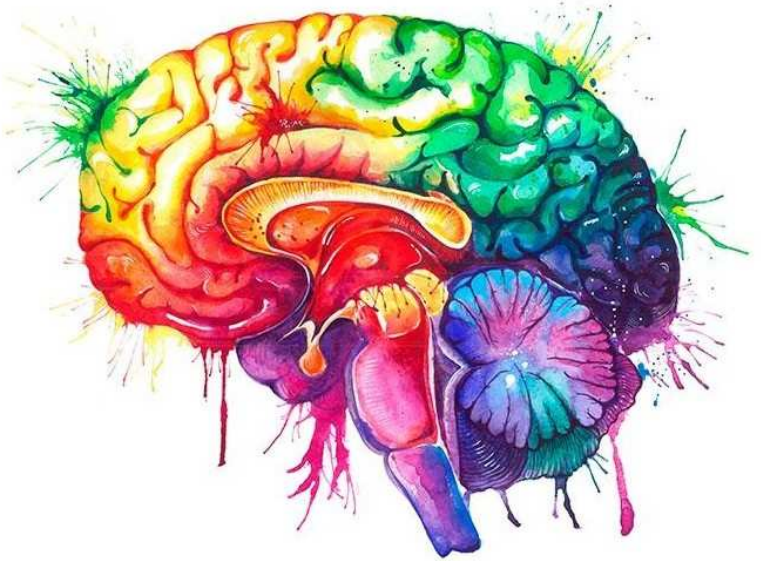
Bonnes pratiques

- Les constantes initiales doivent être visibles sur le tableau et non marquées dans le texte !
- Cela saute plus aux yeux à la coordination médicale, et aussi pour le médecin des urgences.
- Il faut avoir renseigné l'âge pour que les constantes anormales soient en couleur..

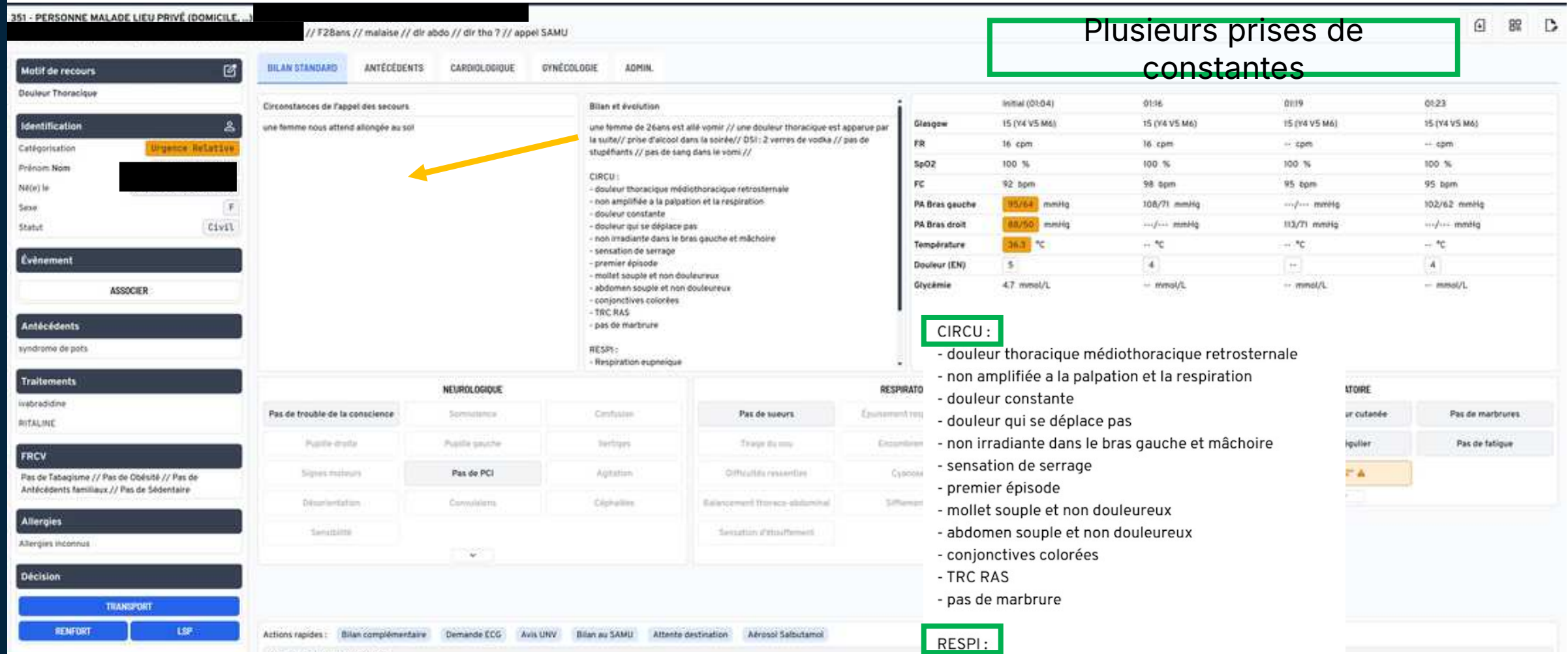
	Initial (10:20)	10:25	10:46
Glasgow	15 (Y4 V5 M6)	--	--
FR	24 cpm	-- cpm	-- cpm
SpO2	98 %	-- %	92 %
FC	118 bpm	119 bpm	166 bpm
PA Bras gauche	96/68 mmHg	100/29 mmHg	127/78 mmHg
PA Bras droit	136/124 mmHg	126/113 mmHg	---/--- mmHg
Glycémie	2.2 mmol/L	-- mmol/L	-- mmol/L

Bonnes pratiques

- En cas de procédure AVC, il faut vérifier qu'une eFiBi n'ai pas déjà été créée par la coordination médicale pour donner des informations qu'on aurait eu à l'appel, comme par exemple le fait que la place ait déjà été régulée dans une UNV…



Que pensez-vous de cette eFiBi ?



Plusieurs prises de constantes

CIRCU :
- douleur thoracique médiothoracique retrosternale
- non amplifiée a la palpation et la respiration
- douleur constante
- douleur qui se déplace pas
- non irradiante dans le bras gauche et mâchoire
- sensation de serrage
- premier épisode
- mollet souple et non douloureux
- abdomen souple et non douloureux
- conjonctives colorées
- TRC RAS
- pas de marbrure

RESPI :
- Respiration eupneique

NEURO :
- bien orienté temps espace
- Bonne motricite sensibilité des 4 membres
- pupilles réactives symétriques de tailles intermédiaire

Que pensez-vous de cette eFiBi ?



- Cause supposée de l'ACR ?
- Devenir de la victime (décédée, transportée) ?
- Obstacle médico-légal ?
- Photo de l'observation de l'UMH ?
- Elle est UA et non UR...

Que pensez-vous de cette eFiBi ?

[redacted] // h 25 ans // palpitations // pas la premiere fois // ECG au départ

MOTIF DE RECOURS
Palpitation - Trouble du rythme

IDENTIFICATION
Catégorisation : Urgence Relative
Prénom Nom : [redacted]
Né(e) le
Sexe : H
Statut : Civil

ANTÉCÉDENTS
Aucun antécédent

TRAITEMENTS
Aucun traitement

ALLERGIES
Aucune allergie

DÉCISION
AJOUTER

ÉVÉNEMENT
ASSOCIER

BILAN STANDARD | CARDIOLOGIQUE | PIÈCES-JOINTES | ADMIN.

Circonstances de l'appel des secours

un homme de 25ans a fait la fête hier soir, a consommé de la cocaine vers 4h du matin, a son réveil ce matin a 9h ressent des palpitations

Bilan et évolution

homme 25ans conscient

CIRCULATOIRE

Ressent des palpitations depuis ce matin 9h00 a son réveil (ne l'as pas réveillé)
(consommation de stupéfiants et d'alcool dans la nuit)
Douleur thoracique associé
latérale gauche qui pique
EN 3/10
Non modifiée a la respiration et a la palpation
douleur constante apparue au repos
non mouvante
mollets souples et non douloureux
1ere fois que ça arrive
pas d'ECG de référence disponible
pas de FRCV

pas de pâleur
pas de tachycardie
tensions et pouls symétrique
pas d'arythmie
conjonctives colorées
TRC -2sec
pas de marbrures

NEUROLOGIQUE

Pas de malaise associé
pas de PCI
nausées présente
pas d vomissements
pas de vertiges
pupilles RAS

INTOX :

STUP : 3 lignes de cocaine a 4h du matin environ
1ere fois qu'il consomme de la cocaine
ALCOOL : 1/2 litre de VODKA au long de la nuit
pas d'autres stupéfiants

RESPIRATOIRE

Pas de difficulté respiratoire ressentie
pas de signes de détresse

	Initial (10:00)	10:16
Glasgow	15 (Y4 V5 M6)	--
FR	14 cpm	-- cpm
SpO2	100 %	99 %
FC	89 bpm	78 bpm
PA Bras gauche	117/76 mmHg	125/81 mmHg
PA Bras droit	123/82 mmHg	---/--- mmHg
Température	36.4 °C	-- °C
Douleur (EN)	3	--
Glycémie	5.0 mmol/L	-- mmol/L

Plusieurs prises de constantes

Que pensez-vous de cette eFiBi ?

Plusieurs prises de constantes

301 - PERSONNE MALADE LIEU PUBLIC (VP, ERP, ...
[redacted] / f 49 / dlr tho / sensation brulure / Ø pci / atcd stent

Motif de recours
Douleur abdominale, distension, ascite, hernie

Identification
Catégorisation: Urgence Relative
Prénom Nom: [redacted]
Né(e) le
Sexe: F
Statut: Civil

Évènement
ASSOCIER

Antécédents
Aucun antécédent

Traitements
Aucun traitement

FRCV
Pas de Tabagisme // Pas de Obésité // Pas de Antécédents familiaux // Pas de Sédentaire

Allergies
Aucune allergie

Décision
TRANSPORT
RENFORT | LSP

BILAN STANDARD | ANTÉCÉDENTS | DIGESTIF | LÉSIONNEL | ECG | ADMIN.

Circonstances de l'appel des secours
Une femme dit avoir une douleur au niveau de l'abdomen, sur l'ensemble de l'abdomen et cephalées.

Bilan et évolution
N : Pas de PCI, pas de PCS, BOTE, pas de signe AVC, Pas de prise d'alcool, ni stupéfiant.

R : Pas de signe de détresse respiratoire, pas de signe de dyspnée, pas de cyanose.

C : Pas de douleur thoracique, pas de marbrure, TRC inferieur à 2 sec. Pas de PRLV. Conjonctives colorées. Pas d'arythmie, mollets souple et non douloureux, pas de voyage récent, fumeuse passive, communauté des gens du voyage hygiène de vie très

DIV : Pas d'évènement particulier.

TRAUMA : Pas de chute, pas de saignement, pas d'hématome, Bonne motricité et sensibilité des 4 membres, Pas de douleur rachis.

Douleur abdominale spontanée, barrière de la langue.

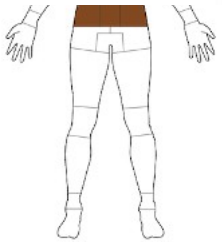
	Initial (00:52)	00:55	00:58	00:59	01:00
Glasgow	15 (Y4 V5 M6)	--	--	--	--
FR	17 cpm	-- cpm	-- cpm	-- cpm	-- cpm
SpO2	96 %	96 %	97 %	96 %	96 %
FC	95 bpm	94 bpm	93 bpm	94 bpm	86 bpm
PA Bras gauche	131/94 mmHg	131/94 mmHg	131/94 mmHg	135/86 mmHg	129/82 mmHg
Température	37.6 °C	-- °C	-- °C	-- °C	-- °C
Douleur (EN)	5	--	--	--	--

NEUROLOGIQUE
Pas de trouble de la conscience | Somnolence | Confusion
Pupille droite | Pupille gauche | Vertiges
Signes moteurs | Pas de PCI | Agitation
Désorientation | Convulsions | Céphalées
Sensibilité

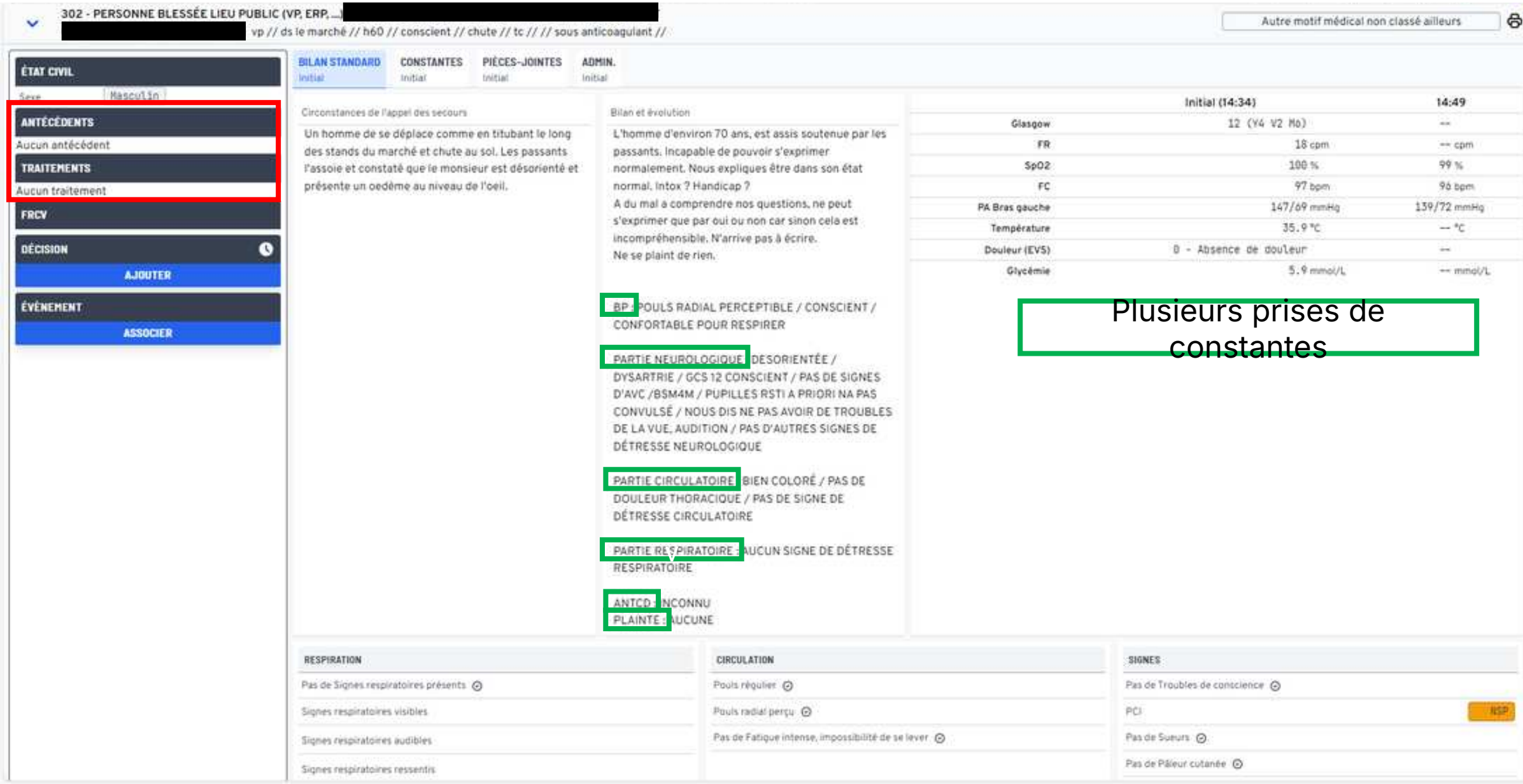
RESPIRATOIRE
Pas de sueurs | Épuisement respiratoire | Essoufflement
Tirage du cou | Encombrement | Toux
Difficultés ressenties | Cyanose | Difficultés à parler
Balancement thoraco-abdominal | Sifflements | Râle
Sensation d'étouffement

CIRCULATOIRE
Pouls radial perçu | Pas de pâleur cutanée | Marbrures
Froideur des extrémités | Pouls régulier | Pas de fatigue
Conjonctives | TRC

Actions rapides : Bilan complémentaire | Demande ECG | Avis UNV | Bilan au SAMU | Attente destination | Aérosol Salbutamol



Que pensez-vous de cette eFiBi ?



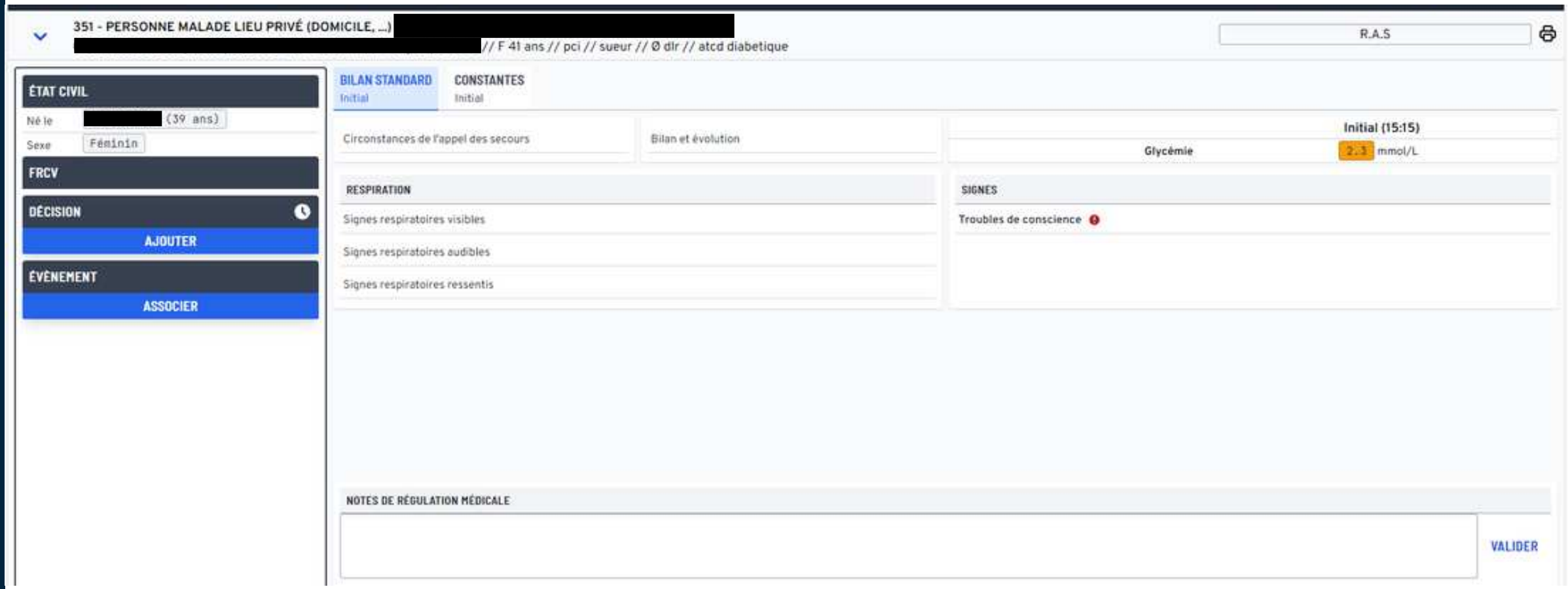
Que penser de cet appel en urgent ?



Rappel :
contact en urgent à la coordination médicale

- Bonjour,
- VSAV……, parti au……,
- CCH/SGT……
- Je vous appelle pour une demande d'équipe médicale
- Je suis face à une détresse
  - Neurologique : coma
  - Respiratoire
  - Circulatoire
- En effet la victime présente :
  - Un coma qui réagit à la stimulation verbale/douloureuse/ne réagit pas, GCS approximatif
  - Polypnée, cyanose, signes de lutte, sueurs
  - Tachycardie, absence de pouls radial, victime gisante, sueurs
  - Circonstanciel

Que penser de cet appel en urgent ?



Conclusion

- Quand une équipe médicale (UMH) est présente sur intervention, il faut tout de même remplir correctement eFiBi : ceci permet d'assurer le suivi des victimes (catégorisation, hypothèses diagnostiques, destination, photo de l'observation médicale).
- Il n'y a pas besoin de remplir complètement eFiBi pour demander une équipe médicale au bilan primaire. Il faut quand même savoir justifier sa demande.
- Il faut faire un effort de présentation dans la rédaction du bilan pour permettre une lecture plus facile, rapide et minimiser les incompréhensions à la transmission du bilan (notamment le circonstanciel).